



Paliativní péče

Výživa u pacientů s demencí - mezi evidencí,
etikou a realitou péče

ÚVOD

Otázka výživy a hydratace v paliativní medicíně je široce diskutována a rozhodnutí o podávání či ukončení nutriční podpory nebývá snadné.

Indikace musí být součástí komplexní, holistické péče, realizované multidisciplinárním týmem.



ÚVOD

Při poskytování paliativní péče je nutné věnovat zvláštní pozornost hodnocení stavu výživy pacienta a včas indikovat nutriční podporu v situaci, kdy pacientovi přináší **prokazatelný benefit**.

Zároveň je nezbytné, aby **cíle intervence** byly reálné.



Cíle péče by měly primárně **následovat hlavní etické principy** "autonomie, činit dobro, neškodit, rozhodovat spravedlivě". Tyto principy platí i pro indikaci jakékoli formy nutriční podpory.

- konkrétní
- měřitelné
- dosažitelné (realistické)
- časově ohraničené (revidovatelné)
- v souladu s přáním pacienta / blízkých



A collection of medical supplies is arranged on a solid blue background. In the upper left, there is a black manual sphygmomanometer with a silver gauge. To its right are two clear plastic syringes. Further right, several white and yellow pills are scattered, along with a small brown glass vial containing more pills. In the upper right corner, a white digital thermometer is visible. Below the thermometer is a white rectangular bandage. In the center, a black stethoscope with a silver chest piece and earpieces is coiled. To the right of the stethoscope is a white blister pack containing 20 white, round tablets. The overall composition is clean and clinical.

V případě, že byl adekvátně
informován, pacient má právo
odmítnout léčbu.

I když by odmítnutí poskytované péče vedlo ke smrti
(včetně nutriční péče).



ROZHODOVÁNÍ O PÉČI

Nutriční stav v době dg. i v průběhu onemocnění je velmi důležitým prognostickým faktorem.

Malnutrice (ve smyslu podvýživy i obezity) stejně tak jako přidružené nutriční poruchy (sarkopenie, křehkost, onemocněním či orgánově specifická kachexie) ovlivňují délku dožití, účinnost léčby, funkční stav i kvalitu života nemocného.

<https://www.cant.cz/seznam-ambulanci/>

info@cant.cz

www.cant.cz



JAK POSTUPOVAT

Čím dříve, tím lépe

Hrubé **seznámení s průběhem onemocnění** a možnými komplikacemi (např. u m. Alzheimer) jsou spojeny s plynulejším průběhem, snížením množství agresivních zákroků v posledních 3 letech života a celkově lepší kvalitou života nemocného.

Naopak **absence “směrníc”** u např. dementních pacientů zvyšuje počet hospitalizací (75% zbytečných), invazivních výkonů, je pro pacienty traumatizující a z velké části **nenaplňuje předpokládané cíle (komfort)**.

Progrese malnutrice je v pokročilejším stádiu onemocnění charakteristický znak.



Věk je významný prognostický faktor,
který je třeba pečlivě posuzovat.

HODNOCENÍ NUTRIČNÍHO STAVU

Stresová malnutrice (akutní) vs. Kachexie (chronická)

V rámci hodnocení nutričního stavu rozlišujeme **akutní či chronické projevy malnutrice**. Zaměřujeme se na výchozí funkční, kognitivní a celkové zdravotní parametry nemocného.

Bereme v potaz sociální, resp. rodinnou situaci.

Kachexie velmi častá u pokročilých stádií onemocnění (rakovina, nemoci ledvin, demence, srdeční selhání) - komplexní problém.

Není řešitelná pouze **“jezením více jídla”**!

Významný nekontrolovatelný úbytek na hmotnosti napovídá end-of-life situaci.

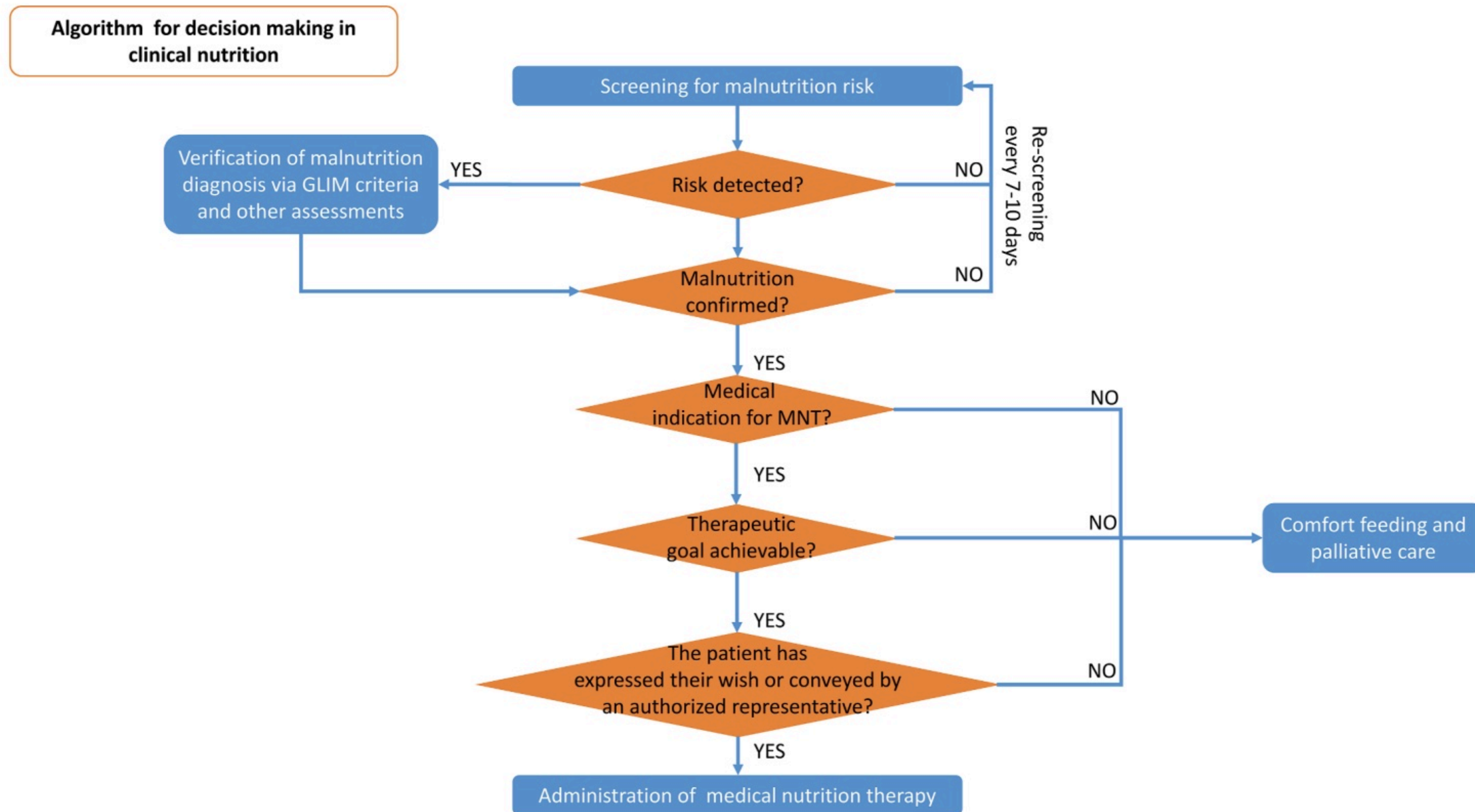
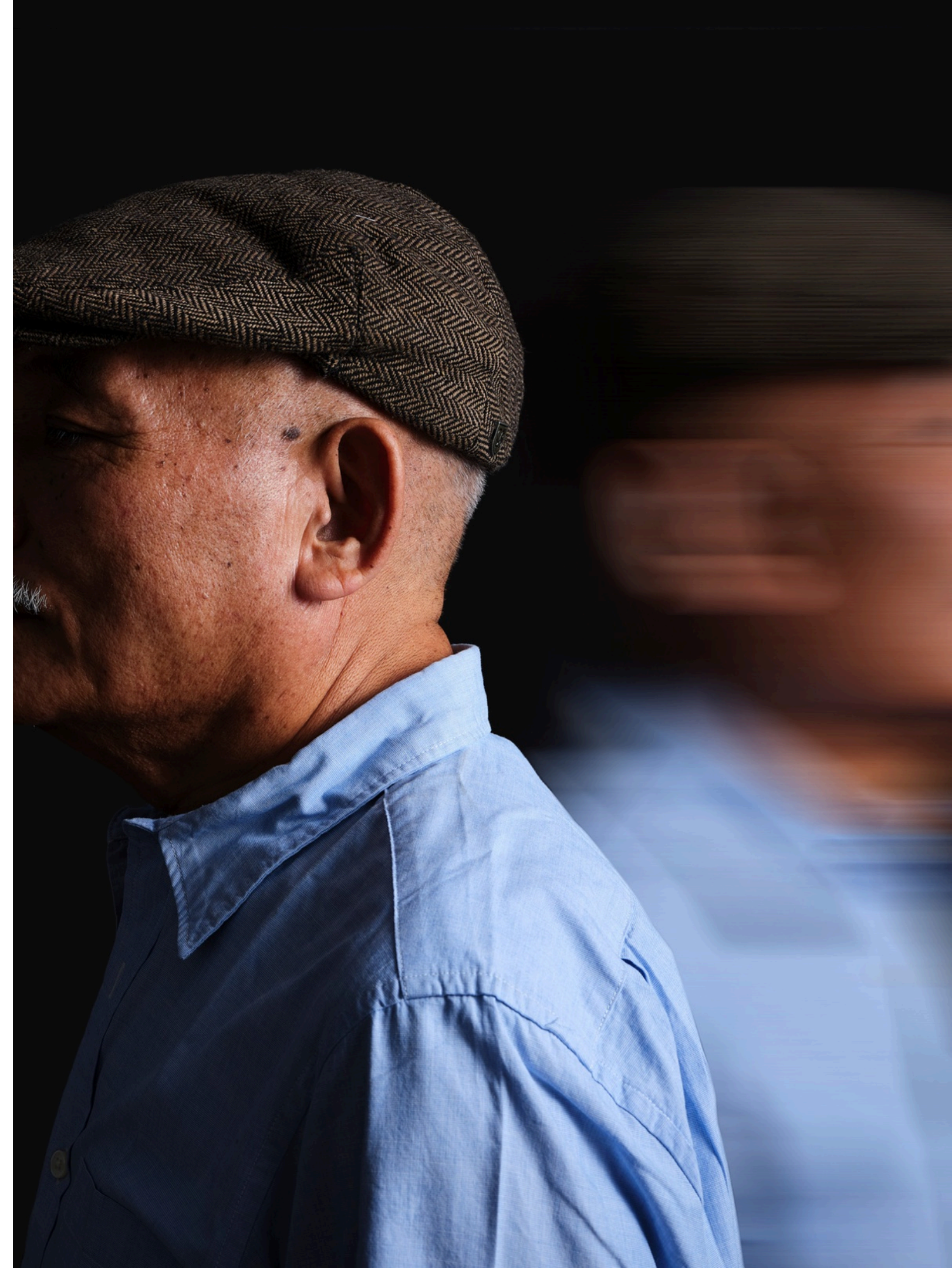


Fig. 1. Algorithm for decision making in clinical nutrition. Abbreviation: GLIM, Global Leadership Initiative on Malnutrition.

Kazuistika:

Pan Jaroslav, 88-letý klient žijící v DZR s dg. m. Alzheimer ve stádiu pokročilé demence, s poruchou polykání (s častým absentujícím polykacím reflexem nebo závažně opožděným, drooling), podávána MUS a zahuštěné tekutiny, příjem stravy 0-25% kvůli obtížím, manželka přítomná při obědě, akcentuje obavy o jeho hmotnost.

Je pro pana Jaroslava optimálním způsobem “comfort feeding”?



Kazuistika:

Jaroslava je klientka s těžkou demencí institucionalizovaná ve Vašem zařízení.

Dcera paní Jaroslavy trvá na krmení Jaroslavy bez ohledu na to, že stravu opakovaně odmítání a velmi malou chuť k jídlu.

Pro koho paní Jaroslava jí?



Vysvětlit, co je demence:

Demence, jejíž nejčastější příčinou je **Alzheimerova choroba**, v průběhu času způsobuje zhoršování různých funkcí mozku, mezi které patří paměť, myšlení, jazyk, plánování a také osobnost.

- problémy s pamětí
- problémy s myšlením a plánováním
- problémy s vyjadřováním
- neschopnost rozpoznávat lidi či věci
- změna osobnosti

Demence je onemocněním progresivním, postupně se zhoršujícím a obvykle v horizontu několika let se u většiny lidí rozvinou problémy se žvýkáním a polykáním.

- pacient má potíže s polykáním některých druhů potravin
- nemusí cítit hlad, nechťejí jíst, přestávají jíst a pít (i bez dysfagie)
- mohou jednoduše zapomínat jíst či jak jíst
- usínají u jídla
- cítit zvýšenou námahu při jídle (skrze funkční deficit), nutná asistence

Tělo se postupně zpomaluje - jeho nároky se mění.

Změny v příjmu stravy, polykání a funkčním stavu napovídají přirozené deterioraci.



Kdy je třeba se o výběr jídla či plánování jiných forem zajímat?

Pacient s poruchou polykání může nechtěně vdechnout jídlo či pití do plic. Tomu se říká “aspirace”, která může způsobit zápal plic.

Porucha polykání je způsobena neschopností pacientů s demencí kontrolovat svaly hrdla. Dále je vhodné si všímat:

- úbytku na hmotnosti
- kašel či sípání během jídla a pití
- vytékání jídla či pití z úst
- části sousta zůstávají v ústní dutině i po polknutí
- dlouhá doba strávená jídlem
- pokud si nejste jistí, zda je pacient hladový či žíznivý

U pacientů s demencí si nikdy nejste jisti, zda cítí hlad či žízeň. Pacienti s velmi těžkou formou demence toto referují pouze zřídka.

- úprava konzistence stravy / tekutin, asistence u jídla / pití
- živení pomocí vyživovací sondy či stomie (vývodu)



Nároky klientů v rezidenční péči se
mění s blížícím se koncem života...

...pokud klient přestává jíst, netrpí.
Neumírá hlady.

Hlad a žízeň...

Jak na ně nahlížíme?

Hlad a žízeň je na konci života spontánně tlumena jako součást metabolických změn. Tím tělo zajišťuje, že hladovění není bolestivé. U zdravého hladovějícího člověka to neplatí stejně.

Hladovění skrze specifické metabolické dráhy aktivuje produkci ketolátů, které indukují pocity sytosti.

Zvyšuje se produkce endogenních opioidů (např. β -endorfin, enkefaliny), které jsou tzv. endogenními opiáty a které mohou být významně více potentní než morfin. Tím je zajištěna relaxace a úleva od bolesti.

Přesněji:

- ketolátky (anorektický efekt + možný mírně sedativní/euforický centrální efekt)
- metabolická acidóza a hypernatremie (mírná otupělost vědomí)
- akumulace endogenních opioidů obecně
- snížená sekrece u dehydratace (méně dušnosti, méně nauzey)
- uremie a další metabolity v terminálním stadiu



Jak bude vypadat, když zvolím úpravu konzistence a asistované krmení? “komfortní krmení”

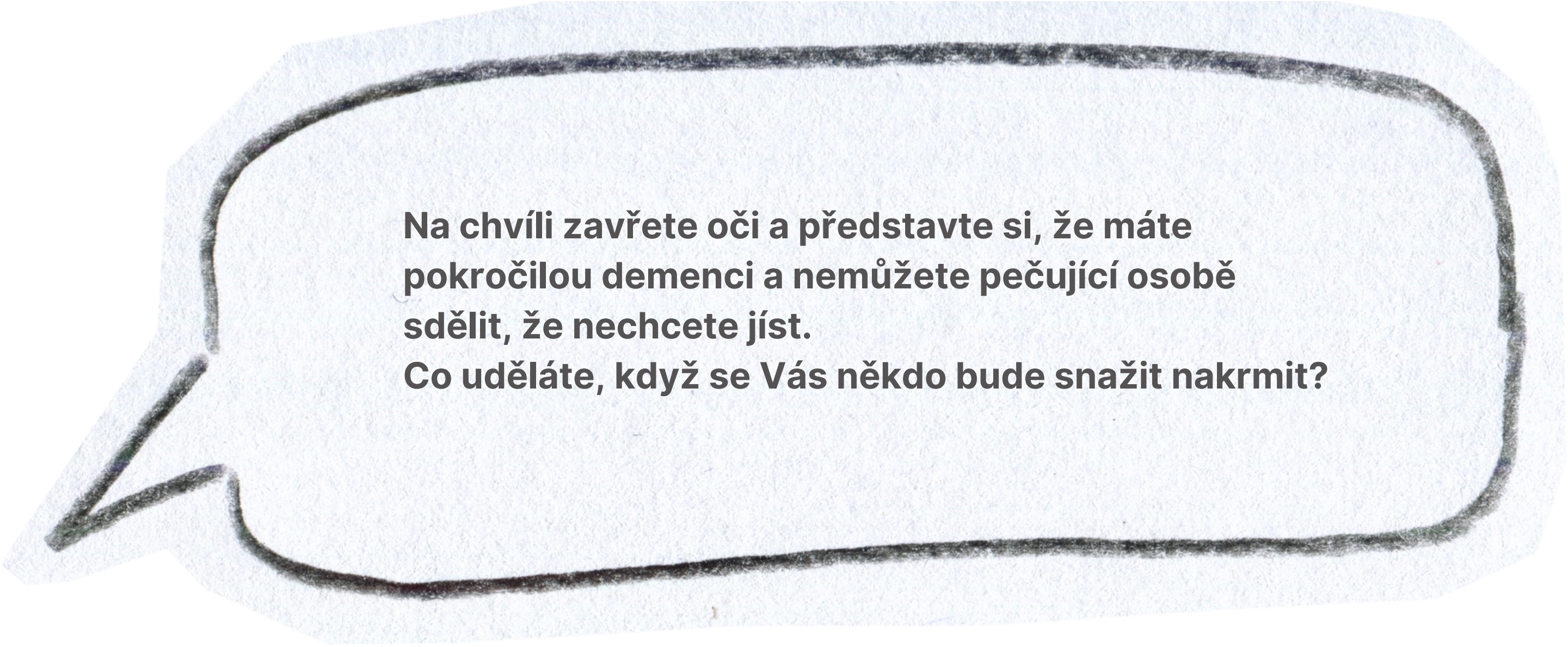
Vysvětlení možností úpravy stravy a tekutin (kdo o ni rozhoduje), popsání principu asistovaného krmení a popis rizik (vyšší riziko aspirace) stejně jako benefitů spojených s krmením (socializace, péče ze strany rodiny), popř. popis postupu krmení ve zdravotnickém či sociálním zařízení.

Klient bude živen dokud a pokud mu krmení nezpůsobuje stres. Jen tolik, kolik sám chce. Hmatatelná alternativa k sondové výživě.

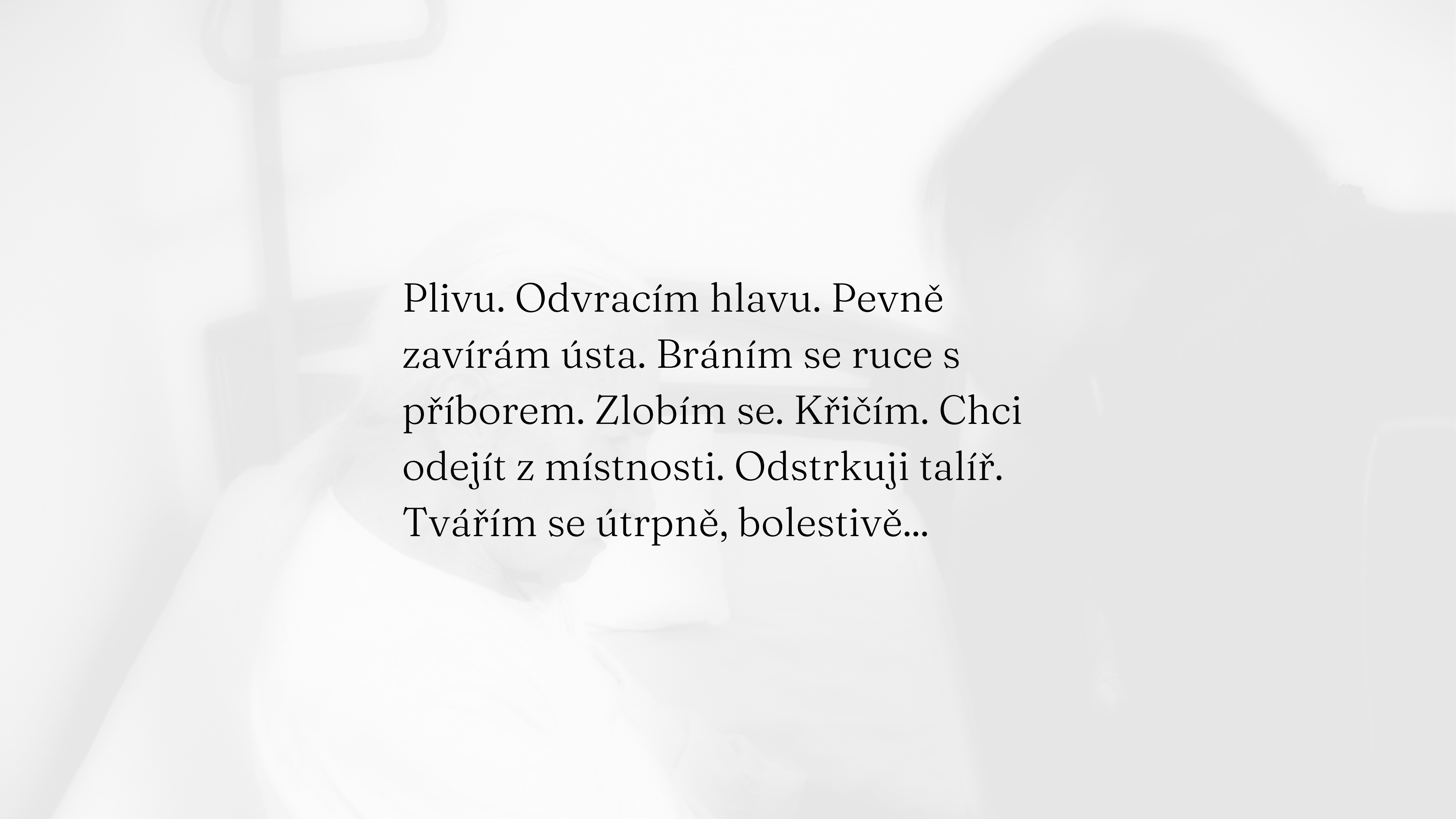
Zodpovězení otázek, které jsou s péčí a krmením spojené:

- Mohou být všichni pacienti s demencí asistovaně krmeni?
- Jak funkční asistované krmení je?
- Co se stane, pokud můj příbuzný nebude schopen nic ústy ujíst?
- Co mohu udělat, abych pomohl mému příbuznému, když nebude moci jíst či pít?





**Na chvíli zavřete oči a představte si, že máte
pokročilou demenci a nemůžete pečující osobě
sdělit, že nechcete jíst.
Co uděláte, když se Vás někdo bude snažit nakrmit?**



Plivu. Odvracím hlavu. Pevně
zavírám ústa. Bráním se ruce s
příborem. Zlobím se. Křičím. Chci
odejít z místnosti. Odstrkuji talíř.
Tvářím se útrpně, bolestivě...

Nepřijímání stravy se stává
významným zdrojem úzkosti všech
osob zapojených do péče...

...snížený příjem stravy neakceleruje
smrt klienta.

Nutnost informací

Lidé s pokročilou demencí se blíží ke konci života života. Sledovat je a jejich nemoc může být těžké pro každého, kdo se o ně stará.

- Důležité je znát, co si přeje (by si přál) pacient a poté jeho příbuzní, tyto informace jsou klíčové při dalším rozhodování o péči
- Pro příbuzné může být velmi stresující a bolestivé vidět svého blízkého odmítat stravu či pití, resp. méně jíst a pít
- Strava i pití je spojováno s “životní silou” a také je silným socializačním prostředkem a je těžké uvažovat v kontextu toho, že může nastat chvíle, kdy osoba blízká “přirozeně” přestane jíst
- Je nutné zvažovat více aspektů - dříve vyslovená přání, náboženské a kulturní hodnoty, co jídlo představovalo pro danou osobu, blízkost druhé osoby a samotná péče (proces poskytování péče milované osobě), trávení času
- Pečlivé zvážení pro a proti individuálně v závislosti na pacientovi

Bez ohledu na množství přijaté stravy je to samotné onemocnění, které pacienta postupně dovede k úmrtí.

Snížený příjem stravy je pouze symptom.

Rodina často ve větší úzkosti z nízkého příjmu stravy než samotný klient.

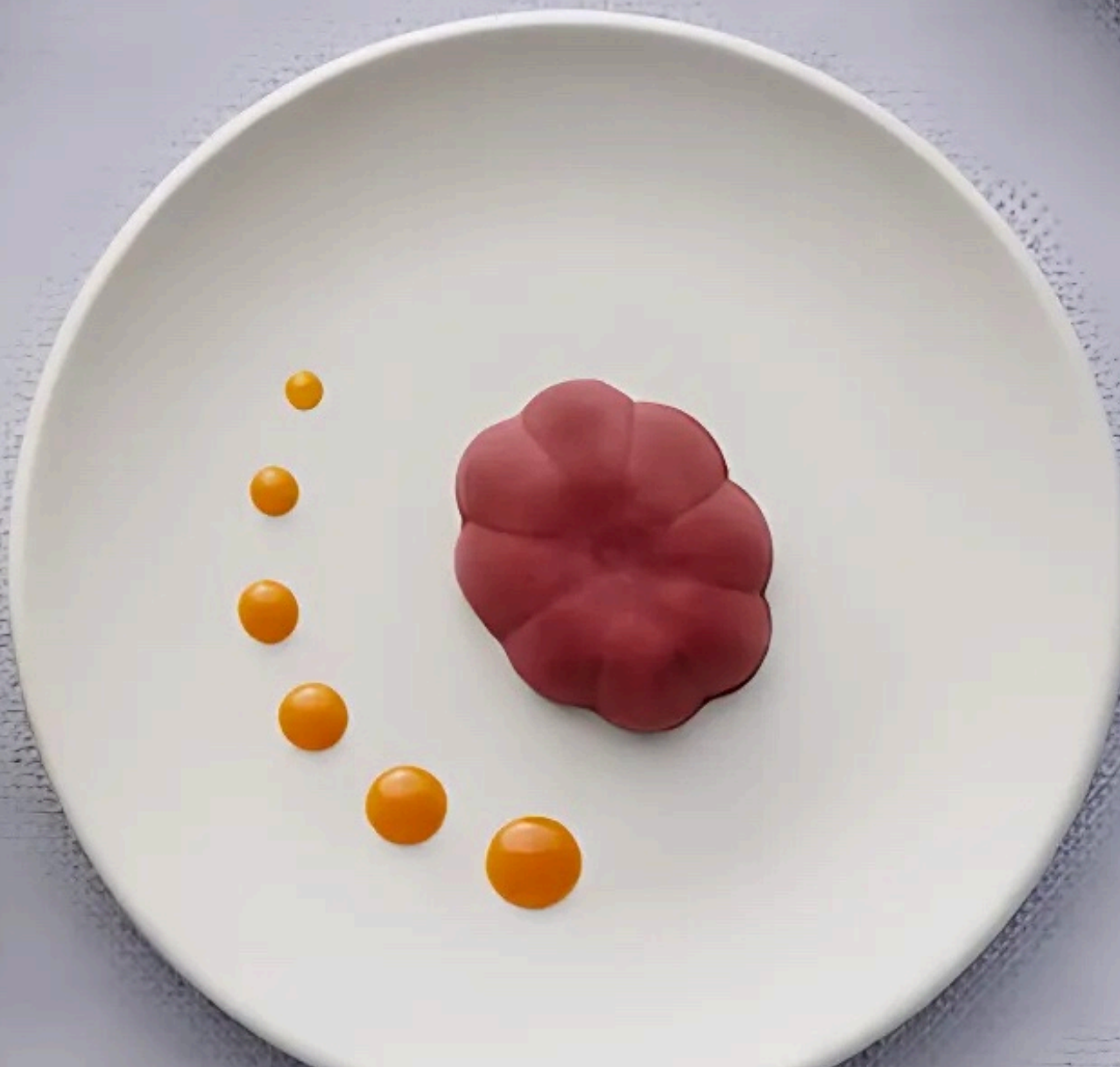




LIST OF *finger foods* FOR DEMENTIA

Dementia Nutrition Solutions







...myslet na to, že intervence v jeden moment přestanou být efektivní.

Ale!

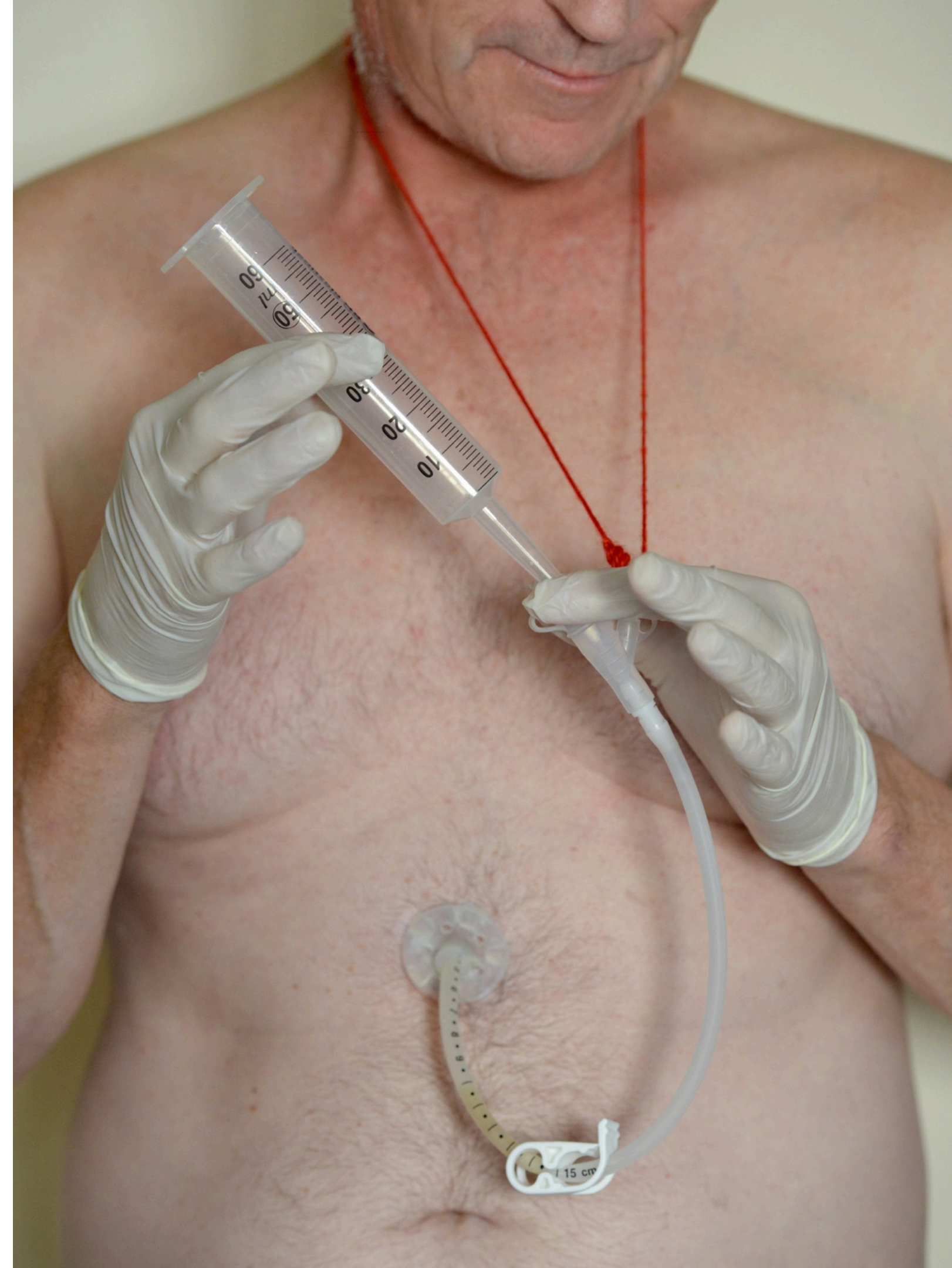
Pokud je pro klienta suplementace bezpečná, užívá si jí (byť malé množství), je na ni zvyklý, preferuje ji více než stravu a poskytuje alespoň minimální komfort pro rodinu, nevysazujeme ji automaticky.

Jak bude vypadat, když bude zvolena sonda / stomie?

Vysvětlení principu zavedení, funkčnosti systému, podávání výživy a péče o výživový vstup (<https://peg.freseniuskabiforum.eu/>)

Zodpovězení otázek, které jsou s péčí a podáváním výživy spojené:

- Musí být pacient upoutaný na lůžko po celý den?
- Dá se sonda / stomie odstranit?
- Bude můj příbuzný žít déle, pokud se rozhodnu pro tento způsob živení?
- Bude mít můj příbuzný se sondou či stomií menší pravděpodobnost, že bude aspirovat, resp. vdechovat jídlo či pití?



Umělá výživa vs. strava per os. Je zavádění NGS či PEG na místě?

Úmrtnost

10-43% - 30 denní úmrtnost (po zavedení PEG)

60-65% - v následujících 12-18 měsících

73-81% - déle než 36-48 měsíců

Benefity

Přístup pro hydrataci a medikaci (snížení bolesti pomocí vstupu)

Rizika

V případě přežití alespoň 60 dní u 70% nezaznamenáno žádné funkční zlepšení

- vyšší zátěž pro pečovatele / rodinu
- zvýšené riziko dekubitů
- zvýšené riziko pneumonie
- zvýšené riziko komplikací





JAKÉ OTÁZKY SI KLÁST?

- Sdělil Vám Váš příbuzný někdy svá přání ohledně léčby, v případě, že bude vážně nemocný?
- Má Váš příbuzný závěť či vyslovila někdy přání či preference ohledně nebo proti aplikaci umělé výživy?
- Jaké jsou přesvědčení a hodnoty příbuzného ohledně lékařské péče, pokud je nemoc závažná a nevyléčitelná?
- Pokud by se Váš příbuzný mohl podívat na výhody a nevýhody, co by si přál nebo vybral?
- A konečně, co je podle Vás v nejlepším zájmu Vašeho příbuzného?
- Očekává lékař / specialista, že se příčina problémů s jídlem / pitím zlepší?
- Jak je pravděpodobné, že se Váš příbuzný s demencí rozruší kvůli “hadičce” a bude potřebovat omezovací prostředky nebo uklidňující léky, aby si ji nevytáhl?
- Bude mít Váš příbuzný se sondou či stomií limitován v péči?
- Má osoba nějaké jiné onemocnění, které ovlivňuje rozhodnutí?
- Zdá se, že Váš příbuzný preferuje příjem potravy ústy?



JAK SE OSOBA ROZHODUJÍCÍ CÍTÍ?

- Cítíte se pod tlakem ostatních?
- Cítíte se rozpolceni mezi vlastním přesvědčením a přesvědčením pacienta?
- Máte nezodpovězené otázky a potřebujete více informací, než se rozhodnete?
- Jaký je váš celkový pocit ze správné volby?

Rozhodující osoba by měla vědět, že může sdílet své obavy a pocity, může se informovat i své rozhodnutí změnit v čase. Měla by znát veškerá rizika i benefity obou možností a zůstat v plném zapojení plánu péče.

Empatie je v komunikaci nezbytná.

“Nenašli jsme žádné důkazy o tom, že by živění sondou či stomií zlepšovalo přežití, zlepšovalo kvalitu života, snižovalo bolest, snižovalo úmrtnost, snižovalo behaviorální a psychologické příznaky demence, vedlo k lepší výživě, zlepšovalo psychologické symptomy rodiny nebo pečovatelů, jako jsou deprese, úzkost, zátěž pečovatelů nebo spokojenost s péčí, a žádné náznaky škodlivosti.

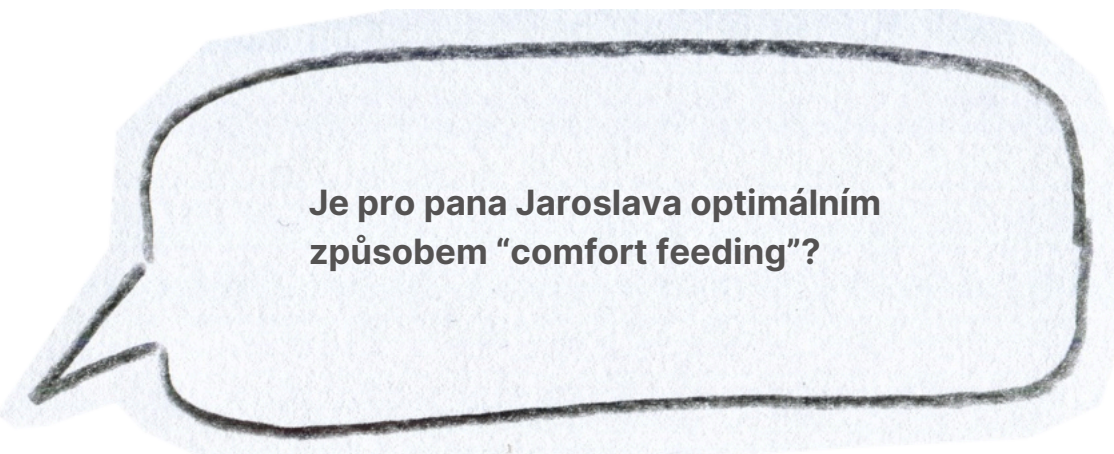
Našli jsme určité důkazy o tom, že existuje klinicky významné riziko vzniku dekubitů při enterálním živění. Budoucí výzkum by se měl zaměřit na hodnotnější výzkum a porovnávání kontrolních a intervenčních skupin a na jasně definované intervence a měření všech zde uvedených výsledků.”



Enteral tube feeding for people with severe dementia (Review)

Davies N, Barrado-Martín Y, Vickerstaff V, Rait G, Fukui A, Candy B, Smith CH, Manthorpe J, Moore KJ, Sampson EL

Jak budeme postupovat u pana Jaroslava v péči?



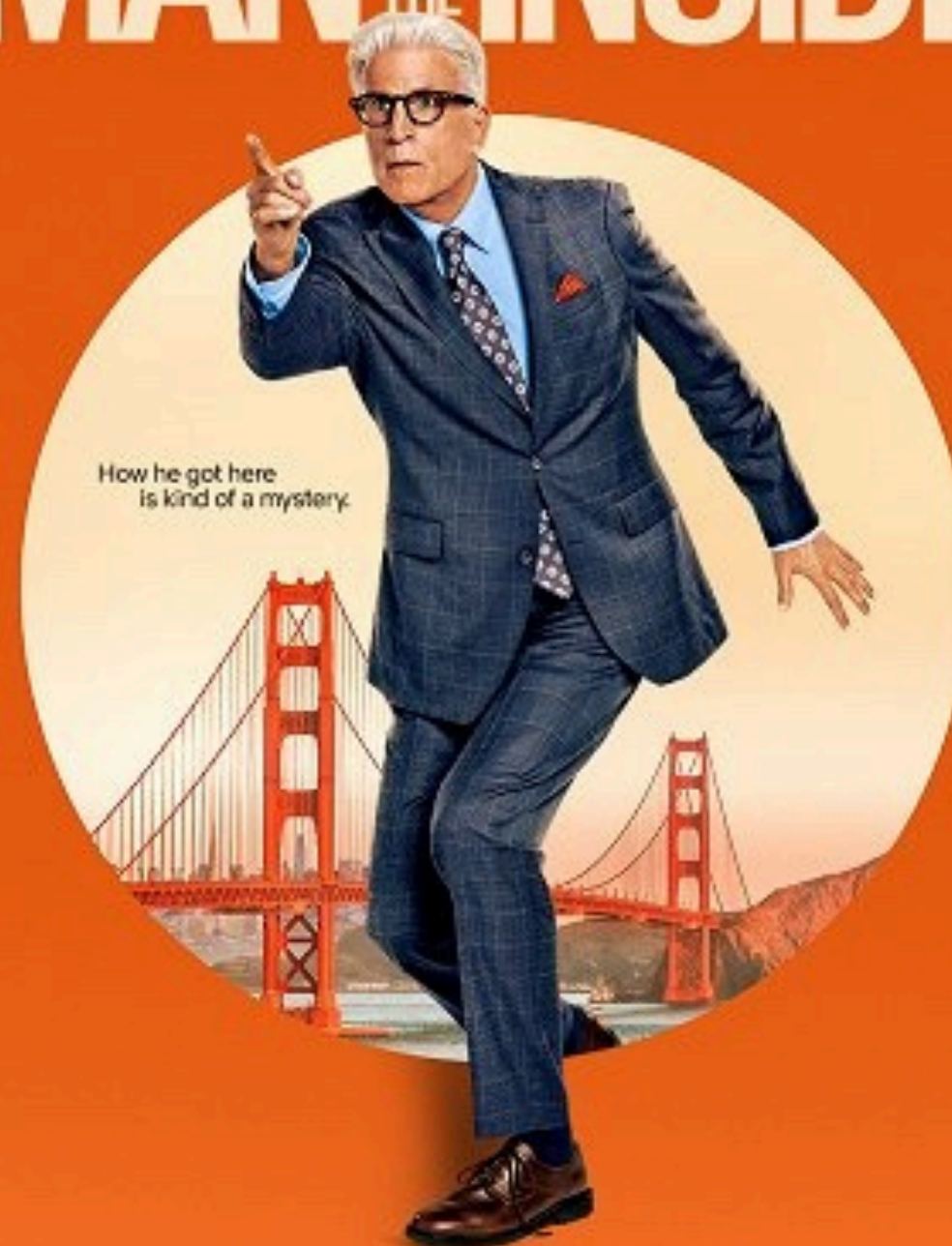
Je pro pana Jaroslava optimálním způsobem “comfort feeding”?

- Informujeme ošetřujícího lékaře o stávající situaci.
- Zavoláme zákonnému zástupci a vysvětlíme, co se v příjmu stravy u klienta změnilo.
- Vysvětlíme, že změny v příjmu stravy napovídají progresi demence a jsou očekávané.
- Vysvětlíme rodině (i pečujícím zdravotníkům) koncept “comfort-feeding”.
- Ujistíme se, že rodina i pečující chápou a přijímají skutečnost, že tento koncept nezajistí nutriční nároky (energetické i v příjmu makro/mikro nutrientů).
- Odpovíme rodině na otázky, které mají.
- Nabídneme jim možnost informování o změně hmotnosti.
- Informujeme pečující tým, že EOL lze očekávat v blízké budoucnosti.



A NETFLIX COMEDY SERIES

A MAN ON THE INSIDE



FROM THE CREATOR OF THE GOOD PLACE
AND CO-CREATOR OF PARKS AND RECREATION

ONLY ON **NETFLIX** | NOVEMBER 21

Rozhodování o aspektech výživy a nutričního stavu je velmi těžké a vyžaduje transdisciplinární přístup.

Základní principy musí vždy zůstat zachovány.

"autonomie, činit dobro, neškodit, rozhodovat spravedlivě"

Thank you!

Tereza Vágnerová, MSc, Eng, PhD
tereza.vagnerova@lf1.cuni.cz